GLOBAL FINANCING FACILITY

SUPPORTED BY WORLD BANK GROUP

L'analyse de couverture dans FASTR

Comment la plateforme compte les personnes à servir, et ce que cela change, étape par étape

FASTR Useful Data

Première partie : le problème, avec un exemple

4 000 enfants vaccinés. Est-ce beaucoup ?



Centre de santé du district

4 000 enfants vaccinés cette année

Beaucoup ? Peu ? Impossible de le dire avec ce seul chiffre.



?

enfants dans le district

Pour répondre, il faut savoir combien d’enfants vivent dans le district.

D'où vient le chiffre qu'on utilise aujourd'hui

Il y a dix ans



Le recensement compte tout le monde

93 000 habitants

Chaque année depuis

+1 an	+2 ans	…	+10 ans
× 1,03	**× 1,03**	**× 1,03**	**× 1,03**
95 800	98 700	…	125 000

On fait grossir le chiffre de 3 % par an, partout. Dix ans plus tard : 125 000.

Puis on prend une part

4 % de 125 000
ont moins d'un an

5 000

enfants « attendus »

C'est ce chiffre, la population cible, qui est inscrit dans DHIS2 et dans les plans.

Il suppose que tout le monde grandit au même rythme et que personne ne déménage.

Mais entre deux recensements, les gens bougent

District A · près de la mine





Des familles sont arrivées

8 000 enfants

la projection en attendait 5 000



déménagement

District B · zone rurale





Des familles sont parties

3 000 enfants

la projection en attendait 5 000

Résultat : des couvertures qui ne veulent rien dire

District A

4 000 enfants vaccinés

5 000 enfants « attendus »

80 %

Le vrai chiffre : 4 000 sur 8 000, soit 50 %

District B

3 300 enfants vaccinés

5 000 enfants « attendus »

110 %

Plus de vaccinés que d'enfants ? Le 5 000 est faux.

Les deux districts ont vacciné correctement. Ce sont les « 5 000 » qui sont faux.

Deuxième partie : comment FASTR compte

L'idée de FASTR : compter là où les gens passent

La plupart des femmes enceintes passent par le centre de santé



Centre de santé



8 femmes sur 10 viennent en consultation prénatale



2 ne viennent pas

Le centre de santé « voit » presque tout le monde. C’est là que FASTR va compter.

Ce que dit l'enquête : 8 femmes sur 10 viennent

L’enquête ménages demande à chaque femme : « êtes-vous allée en consultation prénatale ? »



8 ont répondu oui 2 ont répondu non

Sur 10 femmes enceintes, 8 viennent.

Ce chiffre vaut pour tout le pays et toutes les femmes, vues ou non. Une enquête tous les cinq ans.

Ce que dit DHIS2 : 8 000 femmes sont venues



Centre de santé

Registre DHIS2 · cette année

8 000

premières consultations prénatales

comptées une par une, chaque mois



Ce sont les « 8 sur 10 » : celles qui sont venues

DHIS2 compte les femmes vues. Il ne peut pas compter celles qui ne sont pas venues.

Donc elles étaient 10 000

Si 8 femmes vues vont avec 2 femmes non vues…



8 vues — 2 non vues

… alors 8 000 femmes vues vont avec 2 000 femmes non vues.

8 000
vues au centre de santé (DHIS2)

+

2 000
non vues

= 10 000 femmes enceintes dans le district

Les 2 000 non vues sont déduites des 8 000 vues. Personne ne les a comptées, et pourtant on les a.

La même idée, écrite en calcul

« 8 sur 10 »	8 000 ÷ 0,80	= 10 000
s’écrit 0,80	femmes vues ÷ part des femmes vues	toutes les femmes enceintes

Diviser par 0,80, c’est la même chose que multiplier par 10 et diviser par 8 :

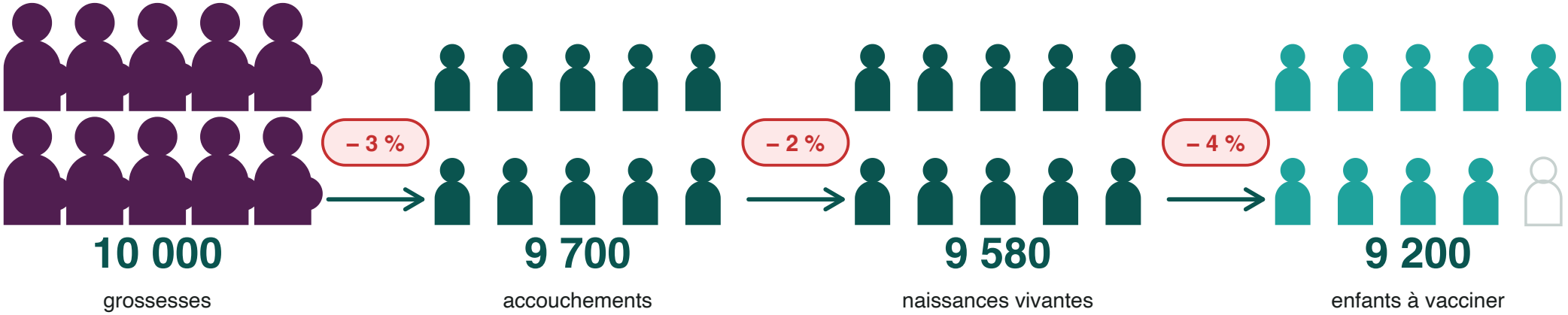
8 000 × 10 ÷ 8 = 10 000

Vous n’avez pas besoin de faire ce calcul. FASTR le fait pour chaque district et chaque année.

Des grossesses aux enfants à vacciner

Toutes les grossesses ne donnent pas un enfant à vacciner

À chaque étape, on en perd une part. Ces taux en rouge sont des taux démographiques : ils changent d'un pays à l'autre.



Chaque pictogramme vaut 1 000 personnes. Le district a 9 200 enfants à vacciner, pas 5 000.

Ces cinq taux sont à régler pour votre pays

FASTR est livré avec des valeurs par défaut. Elles ne sont pas celles de votre pays.

Perte de grossesse	Jumeaux	Mortinatalité	Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale
valeur par défaut	valeur par défaut	valeur par défaut	valeur par défaut	valeur par défaut
3 %	1,5 %	20 ‰	39 ‰	28 ‰
votre pays	votre pays	votre pays	votre pays	votre pays
?	?	?	?	?
source : enquêtes, littérature	source : EDS (DHS)	source : ONU IGME	source : EDS (DHS), ONU IGME	source : EDS (DHS), ONU IGME

Dans la plateforme : Résultats → Paramètres par défaut des modules. Un taux modifié s'applique au prochain paquet de résultats.

La couverture, enfin : 43 %, pas 80 %

Avec la projection du recensement

4 000 enfants vaccinés

5 000 enfants « attendus »

80 %

On croit que le district a presque fini.

Avec le comptage FASTR

4 000 enfants vaccinés

9 200 enfants qui sont vraiment là

43 %

Plus de la moitié des enfants restent à vacciner.

Mêmes 4 000 enfants vaccinés. La décision à prendre n’est pas du tout la même.

Deux règles pratiques pour l'étape 1

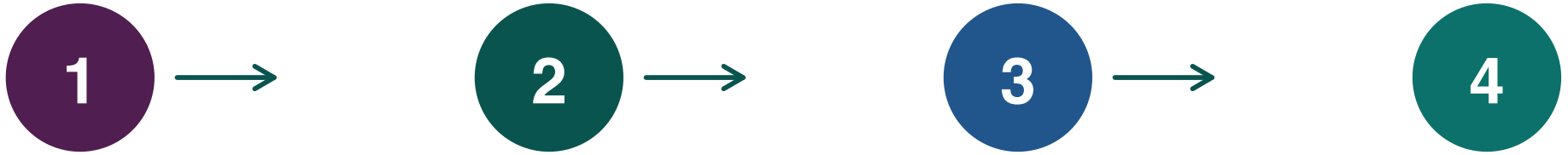
On garde la valeur de l'enquête jusqu'à la suivante. L'enquête de 2021 dit « 8 sur 10 ». Il n'y en a pas eu depuis. Pour 2022, 2023 et 2024, FASTR continue d'utiliser « 8 sur 10 », avec le nombre de consultations de chaque année. Quand une nouvelle enquête sort, elle remplace l'ancienne.

S'il y a deux enquêtes la même année, l'EDS (DHS) passe avant la MICS.

Le même raisonnement marche avec d'autres services. Avec les accouchements en établissement et la part de femmes qui accouchent en établissement, on retrouve le nombre de naissances. Avec le premier vaccin Penta et sa couverture d'enquête, on retrouve le nombre de nourrissons.

Troisième partie : ce que la plateforme fait, dans l'ordre

Quatre étapes, deux modules



Compter à partir d'un service

CPN1 ÷ enquête

Déduire les autres populations

la cascade

Choisir la chaîne la plus crédible

contre l'ONU

Calculer et prolonger

couverture + enquête

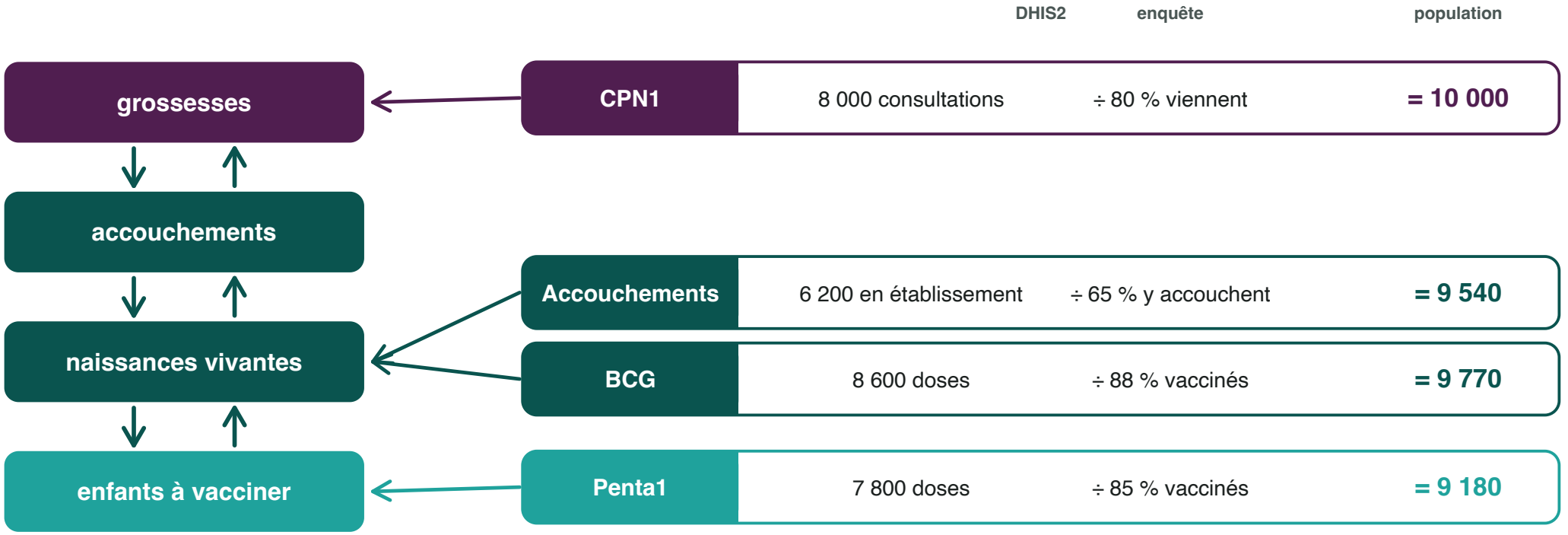
Module « Dénominateurs de couverture » : étapes 1 à 3

Module « Estimations de couverture » : étape 4

Tout cela tourne quand on génère un paquet de résultats. Personne ne fait les calculs à la main.

Étape 1 : quatre services, donc quatre chaînes

Chaque service mesuré par l'enquête donne un chiffre à un étage. La cascade remplit les autres étages.

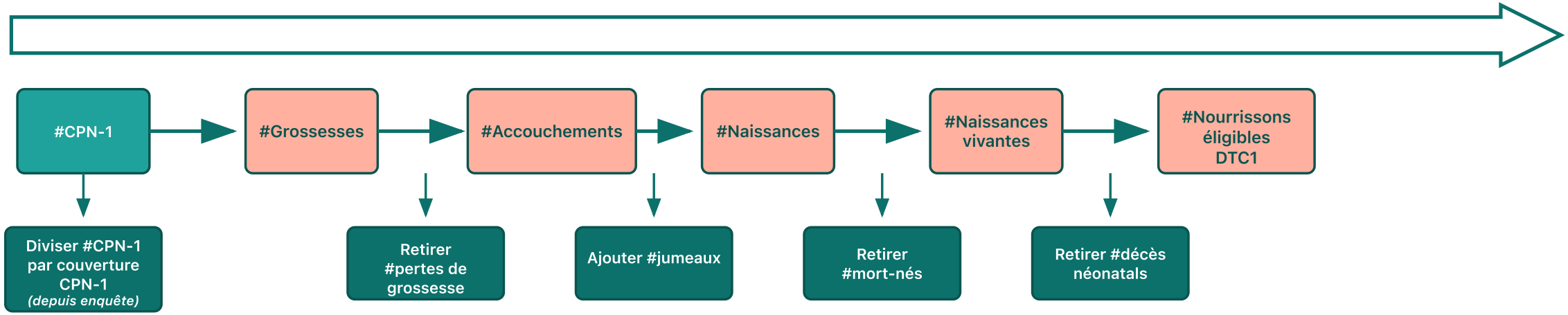


× taux : on descend
÷ taux : on remonte

Accouchements et BCG arrivent au même étage : l'enquête compte les accouchements en établissement parmi les naissances vivantes.

Quatre points de départ, quatre chaînes complètes : quatre réponses à la question « combien de personnes ? ».

Étape 2 : la cascade et ses formules



#Grossesses =#CPN-1/couverture CPN-1	#Accouchements = #Grossesses* (1- Taux perte grossesse)	#Naissances = #Accouchements/(1- (taux jumeaux/2))	#Naiss. vivantes = #Naissances* (1- Taux mortinatalité)	#Nourr. éligibles DTC1 = #Naiss. vivantes * (1- TMN)

Valeurs par défaut	Taux perte grossesse = 0,03	Taux jumeaux = 0,015	Taux mortinatalité = 0,02	TMN = 0,03	TMPN=0,02

Les cinq taux de la cascade

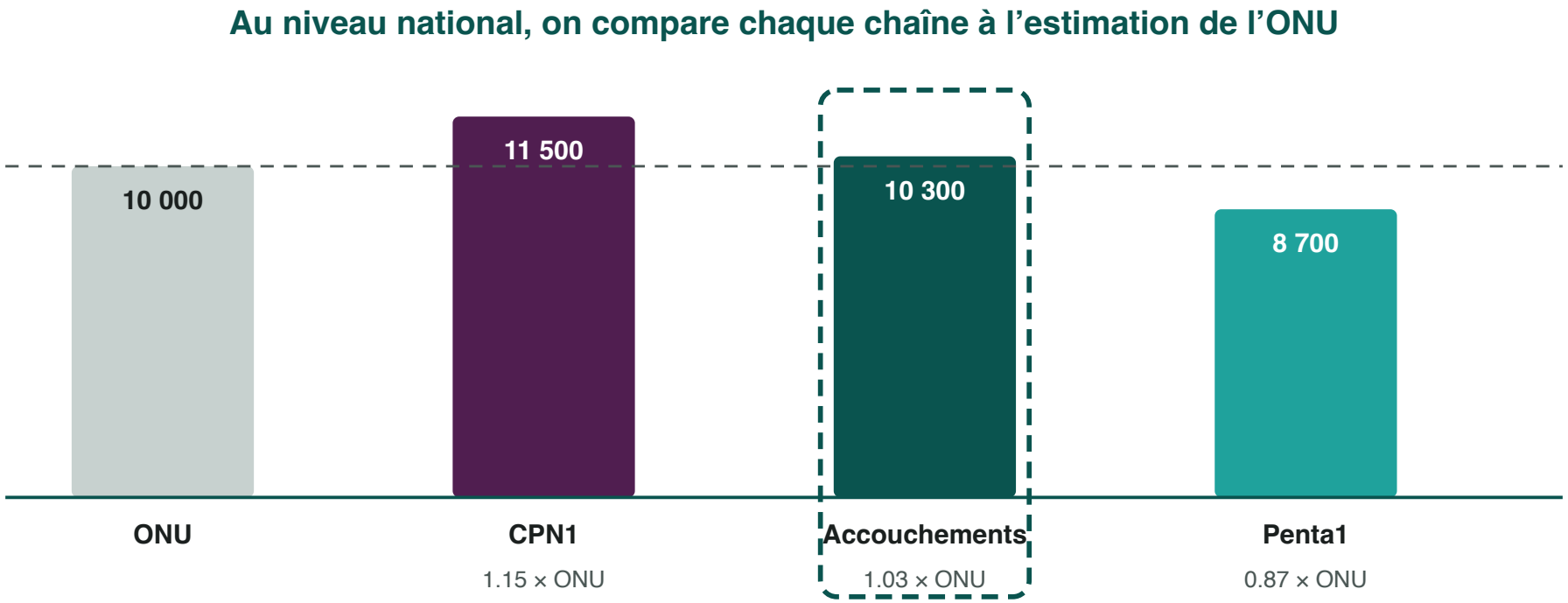
Valeurs par défaut

Taux	Défaut
Perte de grossesse	3 %
Jumeaux	1,5 %
Mortinatalité	20 ‰
Mortalité néonatale	39 ‰
Mortalité postnéonatale	28 ‰

Ce qu'il faut en savoir

- Ce sont des valeurs de départ, pas des valeurs du pays. Elles se remplacent par l'EDS (DHS) ou les estimations UN IGME dans **Résultats → Paramètres par défaut des modules**.
- Un taux changé s'applique à chaque paquet de résultats généré ensuite.
- Au niveau des régions et des districts, ce sont ces taux nationaux qui s'appliquent.

Étape 3 : garder la chaîne la plus proche de l'ONU



La chaîne la plus proche de l’ONU est retenue : ici les accouchements, à 1,03. Une seule chaîne pour tous les indicateurs et tous les districts.

L’ONU n’est pas « la vérité » : c’est un repère indépendant pour départager les chaînes. La chaîne BCG, nationale seulement, ne participe pas au choix automatique.

Étape 4 : calculer la couverture

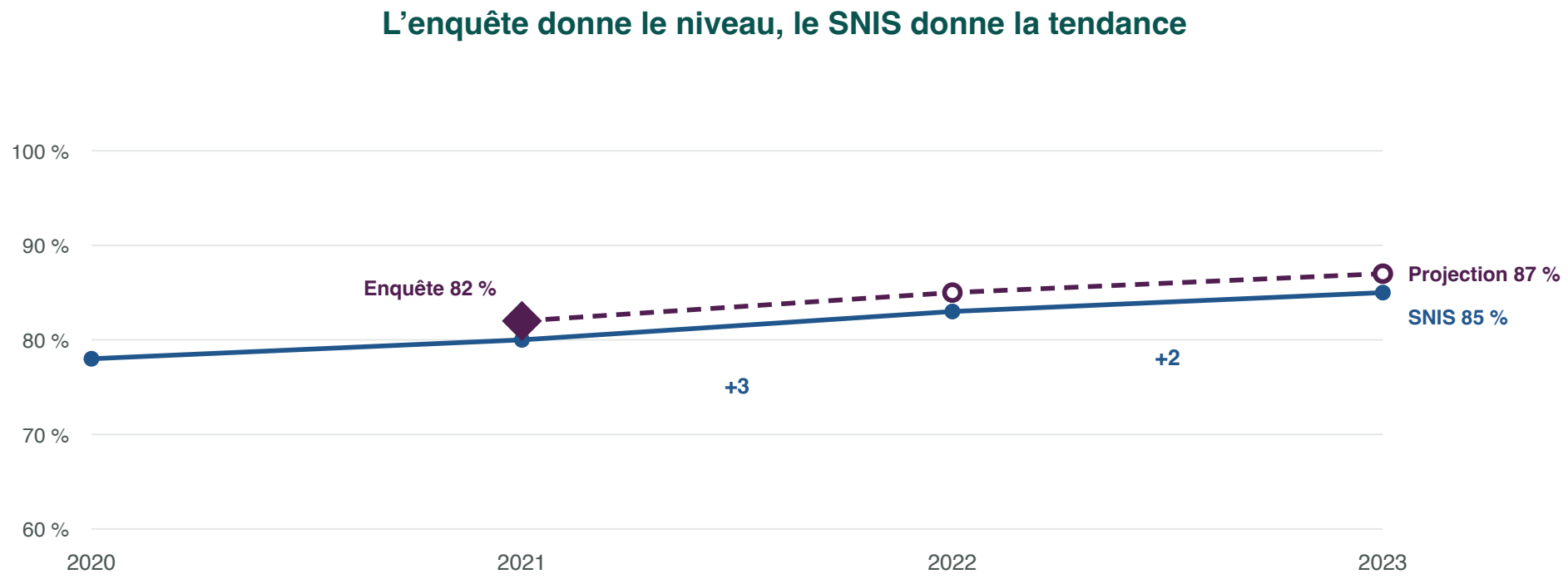
Pour chaque indicateur, chaque année, chaque district

2021	2022	2023
4 000 vaccinés volume SNIS corrigé	**4 600 vaccinés** volume SNIS corrigé	**5 300 vaccinés** volume SNIS corrigé
9 200 enfants dénominateur de la chaîne	**9 400 enfants** dénominateur de la chaîne	**9 600 enfants** dénominateur de la chaîne
43 %	**49 %**	**55 %**

Le volume est celui corrigé des valeurs aberrantes par le module d'ajustement.

La couverture n'est pas plafonnée : au-dessus de 100 %, c'est le dénominateur qu'il faut regarder.

Étape 4, suite : prolonger la dernière enquête



Le SNIS monte de 3 points puis de 2. On part de l’enquête (82 %) et on ajoute les mêmes points : 85 %, puis 87 %.

Quand une nouvelle enquête arrive, la projection repart de sa valeur.

Lire un graphique de couverture

Couverture SNIS

chaque année, chaque district

volume corrigé ÷ dénominateur

Point d'enquête

les années où il y a une EDS (DHS) ou MICS

la mesure de référence

Projection

l'enquête prolongée par le SNIS

national et régions

Pour voir la tendance

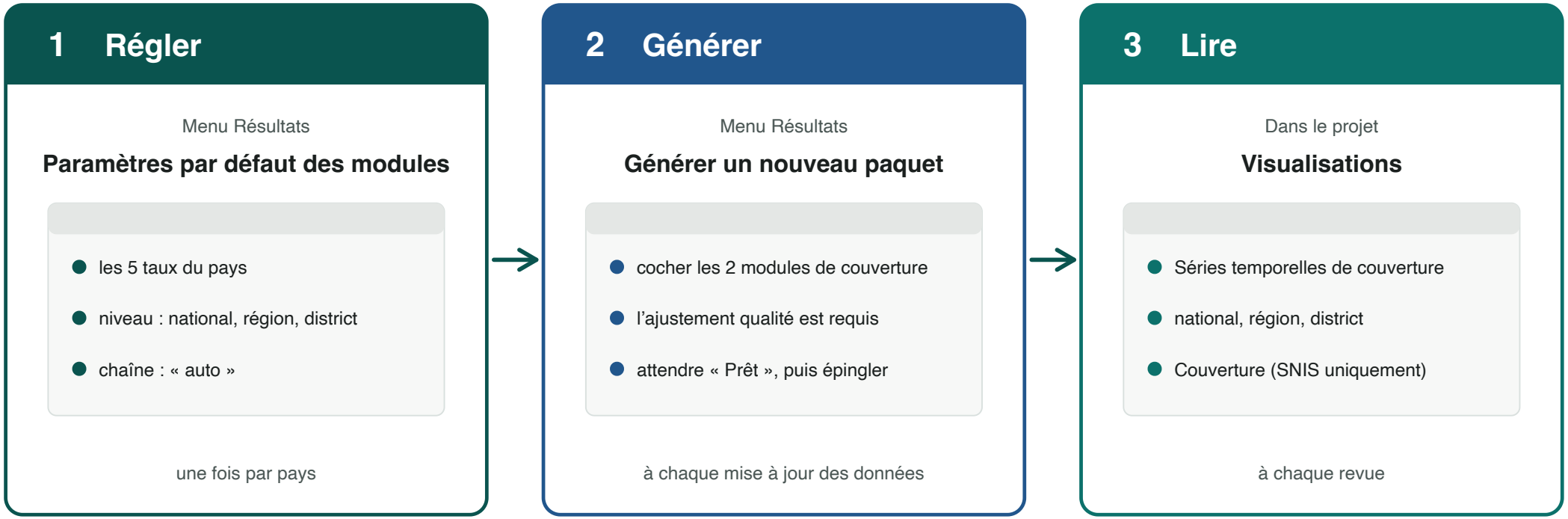
regardez la couverture SNIS :
disponible chaque année et par district

Pour voir le niveau

regardez la projection :
calée sur la dernière enquête

Si les deux séries s'écartent beaucoup, c'est le dénominateur qu'il faut questionner avant les services.

Dans la plateforme : régler, générer, lire



Avant de faire confiance au résultat

Vérifier

- La **dernière enquête** disponible pour le pays est bien celle utilisée
- Les **cinq taux** sont ceux du pays, pas les défauts
- La **chaîne retenue** et sa médiane, dans le journal de génération

Interpréter avec prudence

- Une couverture **au-dessus de 100 %** : dénominateur à revoir
- Un **petit district** : quelques établissements suffisent à faire bouger la courbe
- Un **changement brusque** la même année dans tous les indicateurs : souvent un problème de rapportage, pas de service

En une page

1. Un service mesuré par l'enquête donne une population de départ : volume SNIS ÷ couverture d'enquête.
2. La cascade démographique en déduit les autres populations avec cinq taux.
3. Quatre chaînes sont construites ; celle qui colle le mieux aux projections de l'ONU est retenue pour tout.
4. La couverture est le volume corrigé divisé par ce dénominateur ; la dernière enquête est prolongée par la tendance du SNIS.

Le résultat se lit chaque année et par district, là où les enquêtes ne vont pas.

FASTR

Du volume de service à la couverture, chaque année et par district